PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Lesões do joelho no esporte

Três decisões, da dor anterior ao ligamento

Lesões: Mecanismos, Epidemiologia e Prevenção

TRÊS PERFIS TÍPICOS NA SALA DE ESPERA

Dor na frente do joelho, joelho que inchou em horas, pós-operatório com pressa.



Dor na frente do joelho

há meses; nunca inchou, travou ou falseou

decisão um



Inchou em poucas horas

torceu sem contato, estalo, o joelho saiu e voltou

decisão dois



Pós-operatório com pressa

alguns meses de cruzado, sem dor, quer jogar agora

decisão três

Três decisões diferentes, com urgências diferentes. O que cada profissional precisa reconhecer, encaminhar e parar de fazer.

Reconhecer a dor femoropatelar sem exame

O padrão



piora em flexão sob carga

- escada
- agachar
- cinema

mais depois da atividade que durante

O que ela não tem

- ✕ inchaço
- ✕ travamento
- ✕ falseio

se tem: é a decisão dois

É a queixa de joelho mais comum em quem corre, agacha, e no adolescente que cresce rápido.

NO PRIMEIRO CONTATO

Duas mensagens que mudam o tratamento

“Não é desgaste.”

não é artrose, e o joelho não está acabando; o medo quase sempre vem de laudo mal explicado

“Parar e esperar não resolve.”

uma parte importante continua com dor anos depois; é um dos quadros que mais cronificam

Consenso de dor femoropatelar, Br J Sports Med 2016

CONSENSO DE TRATAMENTO, 2018

O que fazer



Exercício de quadril e joelho

quadríceps e glúteos, carga que progride, por meses

Ajuste de treino

quase sempre houve mudança de carga antes da dor

Palmilha pré-fabricada

apoiada para alívio no curto prazo, como complemento

Bandagem patelar

incerteza

Mobilização isolada, eletroterapia

não recomendadas

Br J Sports Med 2018

E O QUE PARAR DE FAZER

Quatro erros de rotina

Parar e esperar

a força cai e a dor volta pior

Imagem por reflexo

raramente muda a conduta; achados de quem não tem dor

Recurso passivo sozinho

ajuda a atravessar a dor; quem trata é o exercício

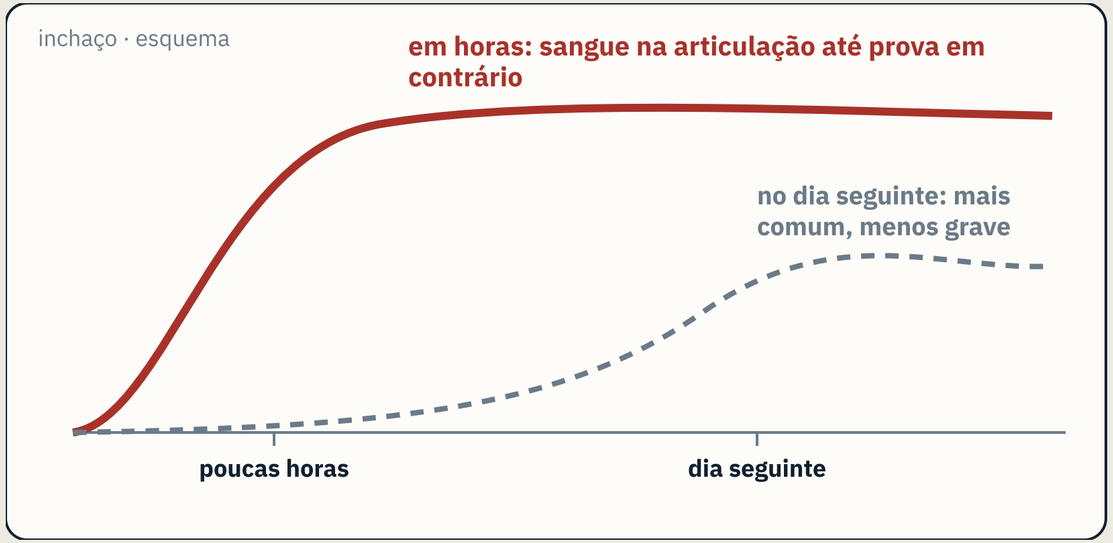
Prometer duas semanas

o quadro leva meses

> No adolescente, a mesma lógica, com o tendão abaixo da patela e a placa de crescimento em mente, e ainda mais paciência.

DECISÃO DOIS · INCHOU EM POUCAS HORAS

Sangue na articulação até prova em contrário



Mecanismo sem contato
mudança de direção, desaceleração, aterrissagem

Estalo
ou o joelho saiu do lugar e voltou

Inchaço rápido
nas primeiras horas, não no dia seguinte

Insegurança
a sensação de que o joelho vai falhar

No esporte, a causa mais comum desse sangramento é a lesão do ligamento cruzado anterior.

NO MOMENTO

O que a comissão faz no gramado

Fazer

- **tirar do jogo, sem negociar**
- **deixar confortável**
- **controlar dor e inchaço**
- **encaminhar para avaliação médica**

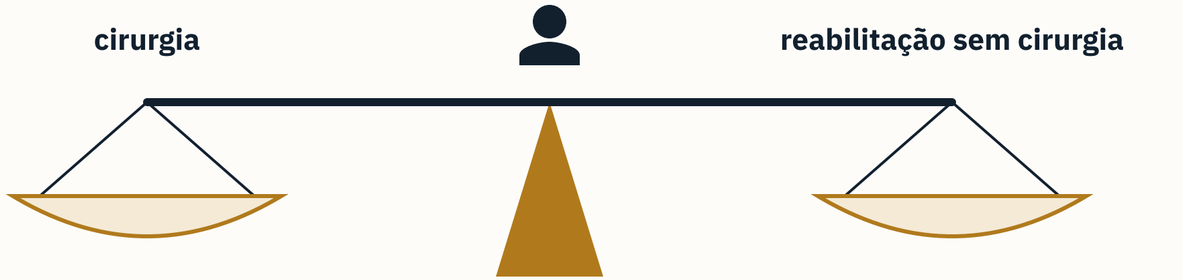
Não fazer

- testar o joelho com adrenalina alta
- **deixar voltar porque a dor passou**
- prometer que “não foi nada”

> Nem todo joelho que incha assim é cruzado: menisco, cartilagem e luxação da patela também incham rápido.

DEPOIS DA CONFIRMAÇÃO

Nem toda lesão do cruzado vai para cirurgia



- esporte e nível
- idade e lesões associadas
- instabilidade no dia a dia
- o que a pessoa quer fazer

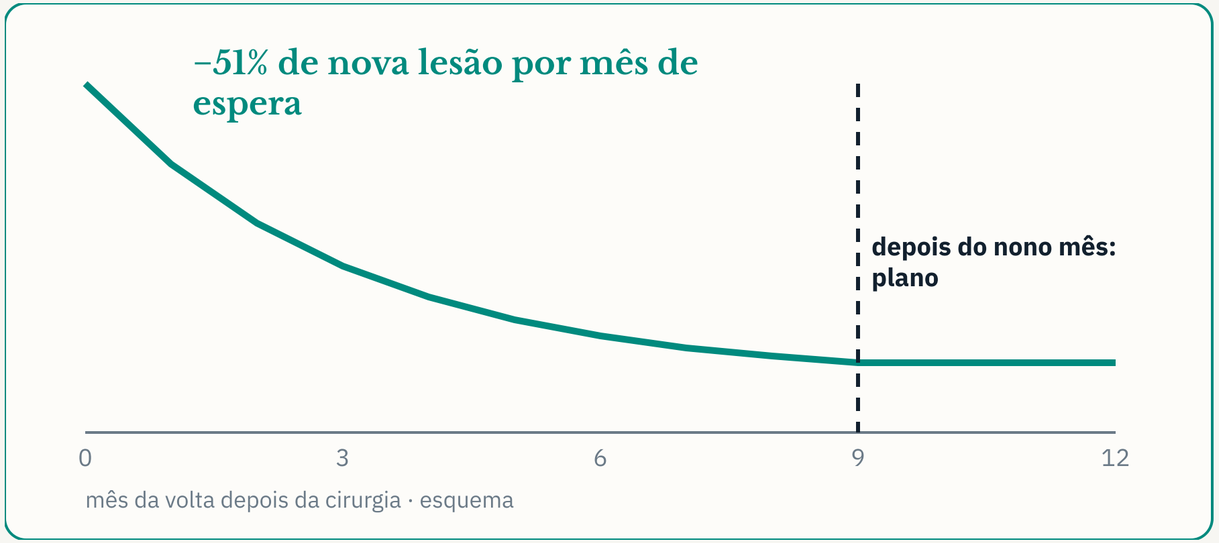
Vale para os dois caminhos

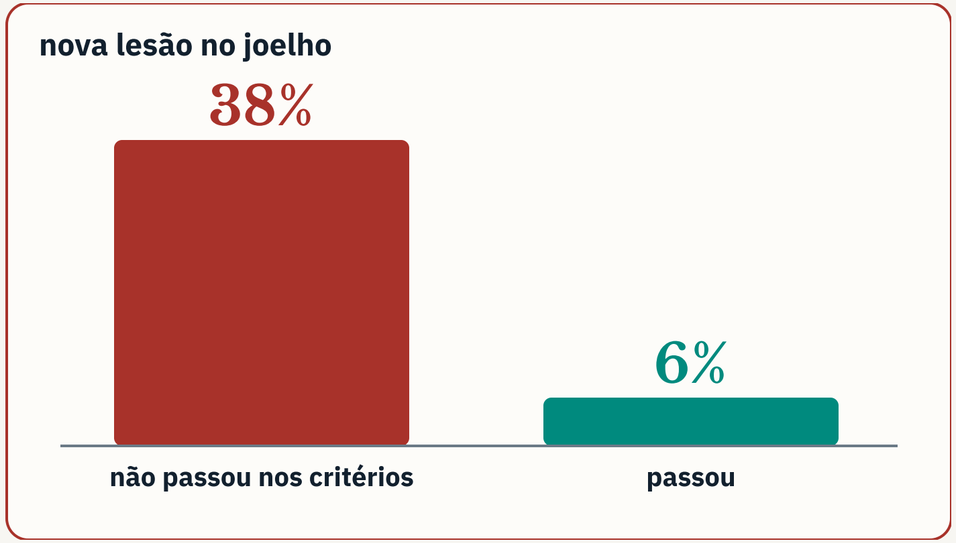
- ✓ **a reabilitação decide o resultado**
- ✓ o tempo é longo
- ✓ dito no começo, não no meio

A decisão é médica e compartilhada. Expectativa mal calibrada no começo vira pressa lá na frente.

DECISÃO TRÊS · COORTE DE DELAWARE E OSLO, 106 ATLETAS

Tempo e critério, os dois





> Depois do nono mês, adiar mais não reduziu o risco. Voltar cedo e voltar sem critério são erros que se somam.

Grindem e colegas, Br J Sports Med 2016

Três regras do retorno

1 Tempo é necessário, não suficiente



9 meses sozinho

nove meses sem critério não libera

2 Critério decide

- **simetria de força do quadríceps**
- **testes funcionais**
- **o gesto do esporte**

3 O prazo se combina no primeiro mês

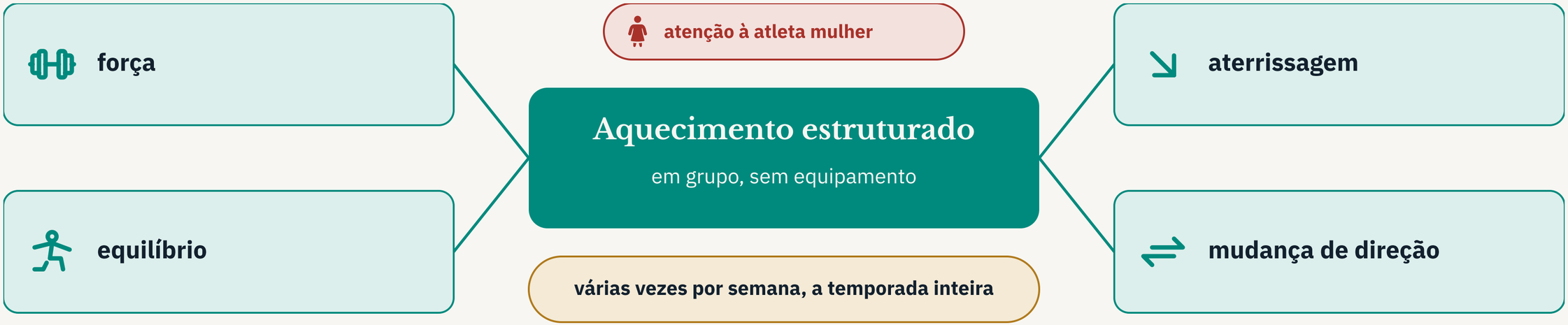
mês 1 combina → **mês 8** cumpre

aí a decisão do oitavo é só cumprir um plano

> Os testes específicos ficam para o módulo de reabilitação.

A PARTE QUE EVITARIA BOA PARTE DISSO

Aquecimento estruturado reduz lesão do cruzado, quando é feito de verdade.



> Os números de efeito e o problema da adesão fecham o módulo.

TRÊS DECISÕES

Reconhecer, encaminhar, parar de fazer

- Dor anterior: exercício de quadril e joelho, por meses
- Inchou em horas: sai do jogo e vai para o médico
- Pós-operatório: tempo e critério, os dois

Médico e fisioterapia

Diagnóstico, cirurgia, testes e liberação.

Preparação e treinador

Força, aterrissagem, prevenção; tirar na hora.

Coordenação

Segura a pressão para a decisão ser clínica.

Próxima aula: tornozelo e ombro.